

Programme de réathlétisation d'un syndrome de la bandelette ilio tibiaie (BIT Syndrom)

Phase	Durée	Objectifs	Exercices détaillés	Fréquence
1. Phase aiguë – Décharge & contrôle de la douleur	Semaine 1–2	◆ Réduire inflammation & douleur ◆ Corriger les facteurs mécaniques ◆ Maintenir mobilité articulaire	◆ Glace localisée : 15-20 min sur la face externe du genou, 2-3x/jour ◆ Repos relatif : arrêt course/sport, privilégier vélo sans résistance si indolore ◆ Étirement passif du TFL/tractus IT : position debout croisée ou latérale couchée, 3x30 sec ◆ Auto-massage au rouleau (foam rolling) : bandelette + quadriceps + fessiers, 2x/jour, 1–2 min ◆ Renforcement isométrique du moyen fessier : position latérale, jambe levée, maintenir 10 sec x 5	Quotidien Étirements : 2–3x/jour Massage : 1–2x/jour
2. Renforcement correctif & stabilité pelvienne	Semaine 3–4	◆ Corriger déficit du moyen fessier ◆ Stabiliser bassin et hanche ◆ Réduire surcharge latérale genou	◆ Side-lying leg raise (avec mini-bande) : 3x15 répétitions ◆ Clamshells avec élastique : allongé côté, genoux fléchis, ouvrir jambe → 3x12 ◆ Pont fessier unilatéral : talon au sol, fessier contracté → 3x10 par jambe ◆ Équilibre unipodal avec reach : toucher avant/arrière/latéral avec jambe libre ◆ Foam roll bandelette + TFL : 1–2 min	4–5x/semaine Étirements + rouleau : quotidien
3. Renforcement fonctionnel & dynamique	Semaine 5–6	◆ Réhabituer à l'impact contrôlé ◆ Travailler stabilisateurs hanche/genou ◆ Reprendre la course progressivement	◆ Step-down latéral (contrôlé) : 3x10 ◆ Squat sumo avec élastique : genoux vers l'extérieur contre résistance → 3x12 ◆ Fentes latérales : 3x10 par côté ◆ Course sur tapis inclinée (faible vitesse) : 5–10 min selon tolérance ◆ Montée sur banc unilatérale : accent sur le contrôle genou → 3x10	3–4x/semaine Course test : 1–2x/semaine Étirements/massage : quotidien
4. Retour au sport spécifique	Semaine 7+	◆ Tolérer course prolongée ◆ Réintroduire travail intense (sprints, côtes, changements d'appuis) ◆ Prévenir rechute	◆ Progression course (run/walk ou 30-30) : alternance marche/course sur terrain plat, puis bosses ◆ Renforcement fonctionnel complet : fentes dynamiques, squats sautés, sauts latéraux ◆ Drills spécifiques (si coureur) : genoux hauts, talons-fesses, foulées bondissantes ◆ Stabilisation dynamique (bosu, saut unipodal) ◆ Contrôle postural global : planche, gainage latéral	Course : 2–3x/sem Renforcement : 3x/sem Étirements : régulier Prévention : 1x/sem min.

Clés spécifiques au BIT syndrome :

- Le problème vient souvent d'un déficit de contrôle pelvien, pas uniquement de la bandelette.
- Le moyen fessier est une cible centrale du programme.
- Les douleurs apparaissent souvent autour de 20–30 min de course → la reprise se fait par alternance course/marche.
- Ne pas trop insister sur l'étirement passif si le fascia est déjà très tendu et douloureux.